

Motif et contexte de la consultation

12 JANVIER 2026

PATIENTE	IDENTIFIANT	CONSULTATION	MÉDECIN
Élise Bernard, 64 ans	DEMO-SAN-064-EB	12 janvier 2026, 09 h 20	Dr M. Alvarez (fictif)

S — Motif rapporté par la patiente

Consultation de suivi programmée. La patiente signale une fatigue en fin de journée depuis environ trois semaines, sans douleur thoracique ni dyspnée d'effort. Elle décrit une consommation de boissons irrégulière et rapporte avoir réduit les liquides le soir de sa propre initiative.

O — Éléments objectifs relevés ce jour

TENSION ARTÉRIELLE

138 / 84 mmHg, bras gauche, assise

FRÉQUENCE CARDIAQUE

76 / min, rythme irrégulier connu

POIDS

68,4 kg — stable depuis la dernière visite

AUSCULTATION

Bruits du cœur irréguliers, pas de souffle nouveau

Antécédents retenus au dossier

- Hypertension artérielle, suivie depuis 2017.
- Fibrillation atriale permanente, diagnostiquée en 2021, sous anticoagulation orale.
- Dyslipidémie traitée.
- Pas d'antécédent chirurgical récent ni d'hospitalisation dans les douze derniers mois.

Éléments de contexte recueillis

La patiente vit à domicile, sans aide professionnelle. Elle gère seule la préparation de ses traitements à l'aide d'un semainier. Elle déclare une bonne observance et n'a pas signalé d'oubli de prise au cours du dernier mois.

Aucun accompagnant n'était présent lors de la consultation.

Allergies et biologie antérieure

PAGE 2 / 3

ALLERGIE DOCUMENTÉE

AMOXICILLINE — éruption cutanée généralisée documentée en 2019, régressive à l'arrêt. Mention reportée dans le dossier de suivi et confirmée par la patiente ce jour.

Autres intolérances déclarées

Aucune autre allergie médicamenteuse connue. La patiente ne rapporte ni allergie alimentaire ni réaction aux produits de contraste iodés. Les intolérances digestives signalées avec un ancien traitement ne sont pas qualifiées d'allergie.

Dernier bilan biologique disponible

PARAMÈTRE	VALEUR	DATE	INTERVALLE DE RÉFÉRENC
Débit de filtration glomérulaire estimé	68 mL/min/1,73 m²	Septembre 2025	> 60
Créatinine	82 µmol/L	Septembre 2025	45 – 84
Potassium	4,4 mmol/L	Septembre 2025	3,5 – 5,0
Hémoglobine	13,1 g/dL	Septembre 2025	12,0 – 16,0

Traçabilité de l'information sur l'allergie

SOURCE	DATE	MENTION PORTÉE
Compte rendu de dermatologie	2019	Éruption sous amoxicilline, régressive à l'arrêt
Dossier du cabinet	Depuis 2019	Allergie documentée, bandeau permanent
Déclaration de la patiente	12 janvier 2026	Confirme l'épisode de 2019

Valeur de septembre 2025 retenue comme référence rénale de départ pour le suivi longitudinal du dossier.

Traitements actifs et conduite à tenir

PAGE 3 / 3

MÉDICAMENT	DOSE	MOMENT DE PRISE	INDICATION
Rivaroxaban	20 mg	Le soir	Fibrillation atriale
Ramipril	5 mg	Le matin	Hypertension artérielle
Bisoprolol	2,5 mg	Le matin	Contrôle de la fréquence
Atorvastatine	20 mg	Le soir	Dyslipidémie

A — Appréciation

Situation cardiovasculaire stable sur les éléments disponibles ce jour. La fatigue rapportée n'est pas expliquée par les constantes relevées. Apports hydriques probablement insuffisants selon l'interrogatoire.

P — Plan

- Poursuite du traitement en cours sans modification à cette consultation.
- Renouvellement de l'ordonnance prévu dans les jours suivants.
- Conseils d'hydratation régulière, y compris en période de chauffage.
- Bilan biologique de contrôle à prévoir dans le semestre.

Éléments de surveillance rappelés à la patiente

- Signaler tout saignement inhabituel, en particulier digestif ou urinaire.
- Ne pas interrompre l'anticoagulant sans avis médical.
- Signaler tout épisode de diarrhée, de vomissement ou de fièvre prolongée pouvant entraîner une déshydratation.
- Apporter la liste complète des traitements à chaque consultation.

Aucune modification de dose n'est décidée le 12 janvier 2026.